

PROJET DE FIN DE FORMATION



Etude des facteurs de réadmission de la patientèle diabétique

Audric Cologne - Valentin Rouquier

Etats-Unis 1999-2008



En 2002 :

160* mds\$

de dépenses de santé imputés aux
malades atteints du diabète.

sur

865 mds\$

*de dépenses totales pour la santé
des américains*

soit

18.5%

de part de dépense liée au diabète
uniquement.

En 2004 :

6.29** millions

d'hospitalisations

pour diabète - posé en primo
diagnostic ou second.

sur

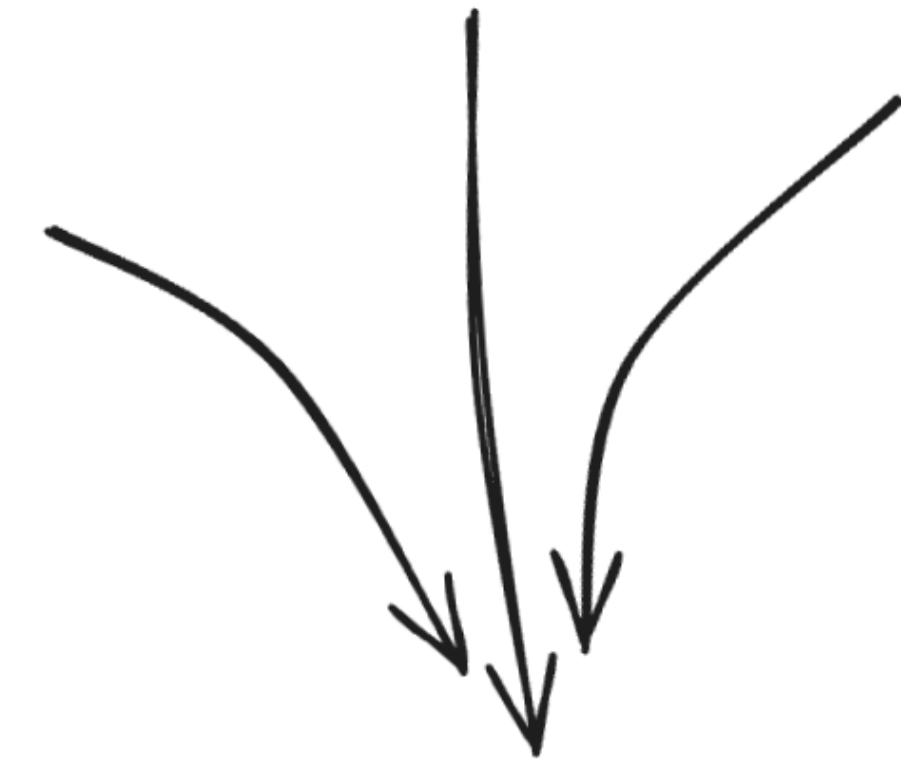
38.66 millions

d'hospitalisations

soit

16.3%

des hospitalisations totales liées au
diabète.



**Le diabète, un fardeau
économique et un poids lourd
pour le système de santé
américain.**

*Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2002", Diabetes Care

**HCUP Statistical Brief #17 - 2004



11 millions d'américains, soit 4% de la population touchée en 2000

29 millions d'américains*, soit 8.4% de la population touchée en 2023

*diagnostiqués uniquement

Le diabète: une pathologie du présent, un défi pour l'avenir.

Maladie chronique caractérisée par la production insuffisante d'insuline par le pancréas ou sa mauvaise utilisation dans l'organisme



Des séjours longs et coûteux
(Durée moyenne d'une hospitalisation en jour)

4.40

soit 7500\$ en moyenne*



Un suivi régulier nécessaire
(nombre moyen de visite(s) annuelle(s))

1.71



Une posologie lourde
(Nombre moyen de médicaments pris par patient)

22.80



Le patient type :

Tranche d'age
[inclus - exclu)

[70-80)

Ethnie

Caucasian

Genre

Female



Un taux de réadmission élevé

sous 30 jours

12.35 %

contre une fourchette 8,5-13,5% pour les autres pathologies après 2007**

25mds\$* de dépenses attribués aux réadmissions
sous 30 jours en 2012

Les réadmissions: un enjeu humain et financier.

pénible pour les patients, un poids supplémentaire pour le
personnel médical en souffrance :
20% des postes d'infirmiers étaient vacants en 2000 en
Californie*

<30 jours -> fenêtre choisie par Medicare/CMS qui a introduit des
pénalités financières en cas de taux trop élevé - compromis permettant de
capter les réadmissions évitables liées aux soins, assez long pour ne pas
exclure les complications qui mettent quelques semaines à se déclarer.



Le batch
étudié :

Nombre d'hospitalisations recensées sur la
période

1999-2008

101 766K

Nombre de patients recensées sur la
période

1999-2008

71 518K



Ethnie

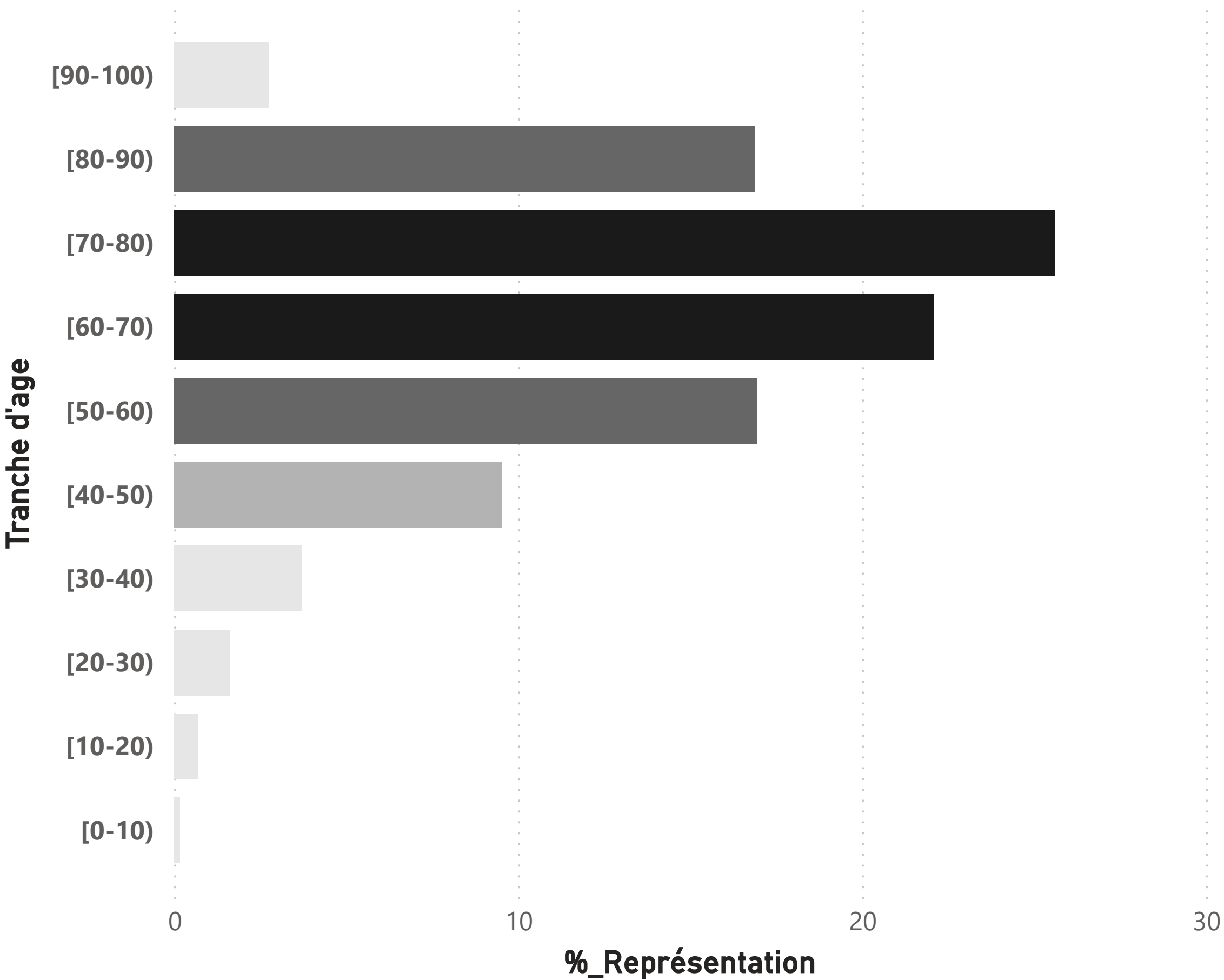
Genre

Tranche d'age

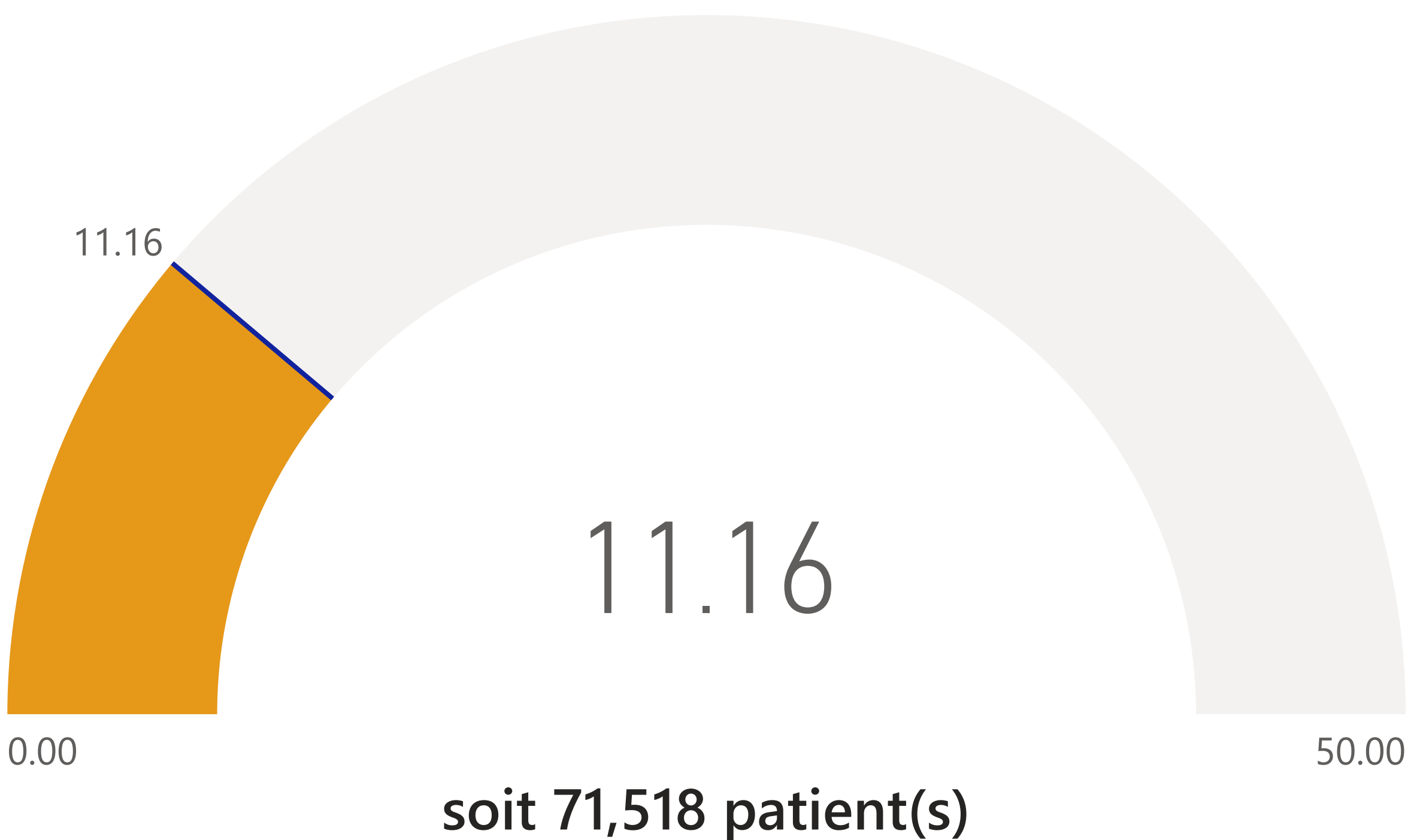
Dosage Insuline

Tous égaux devant la réadmission ?

Taux de représentation hospitalier



Taux de réadmission hospitalier



Visites par patient (sous 1 an pre-hospitalisation)

0

80

Nombre de médicaments prescrits

1

81

Nombre de changement de posologie

0

4

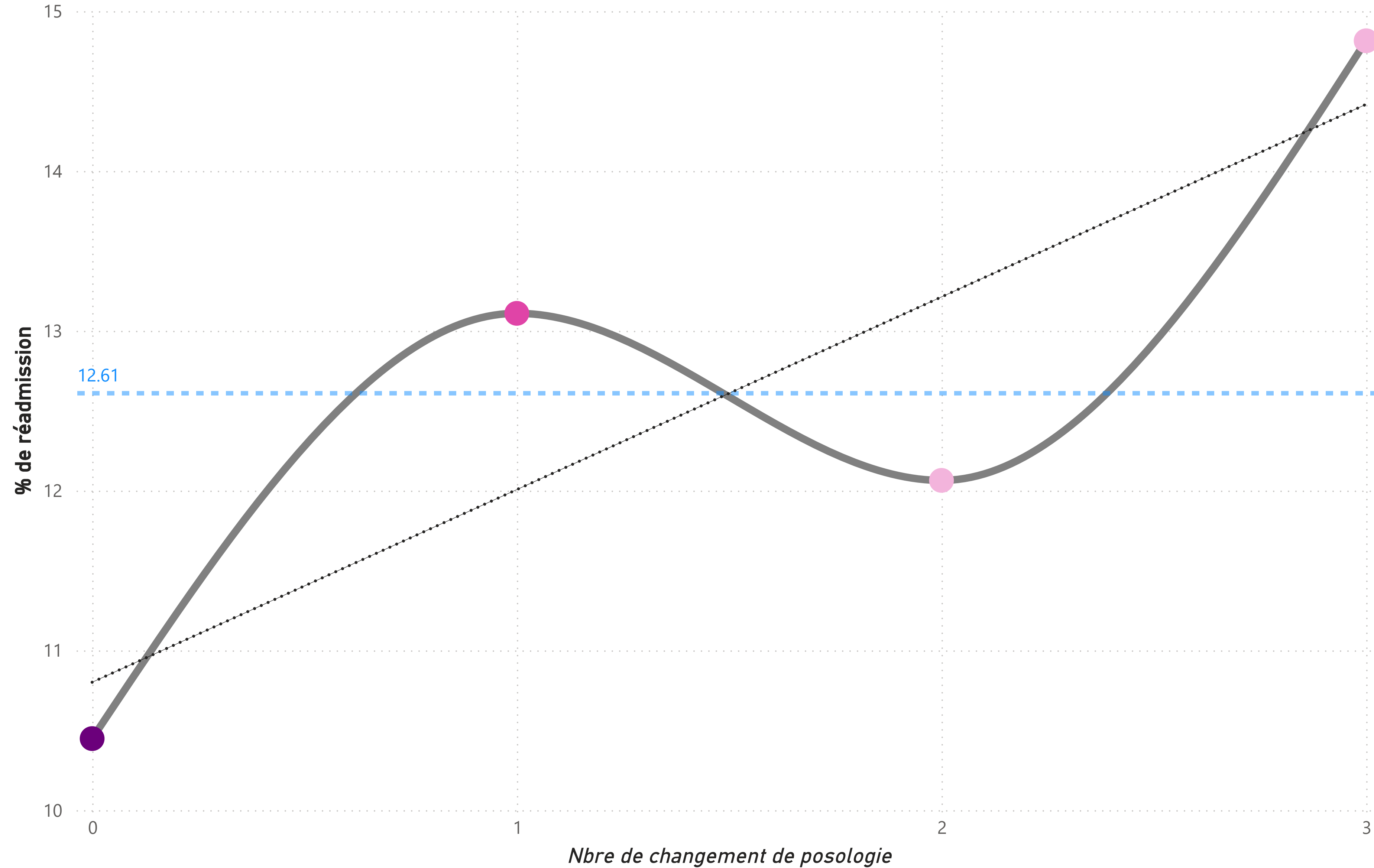
Duree de l'hospitalisation

1

14



Réadmission : des facteurs forts ?



● < 5000 patients ● < 10000 patients ● < 20000 patients ● + 20000 patients

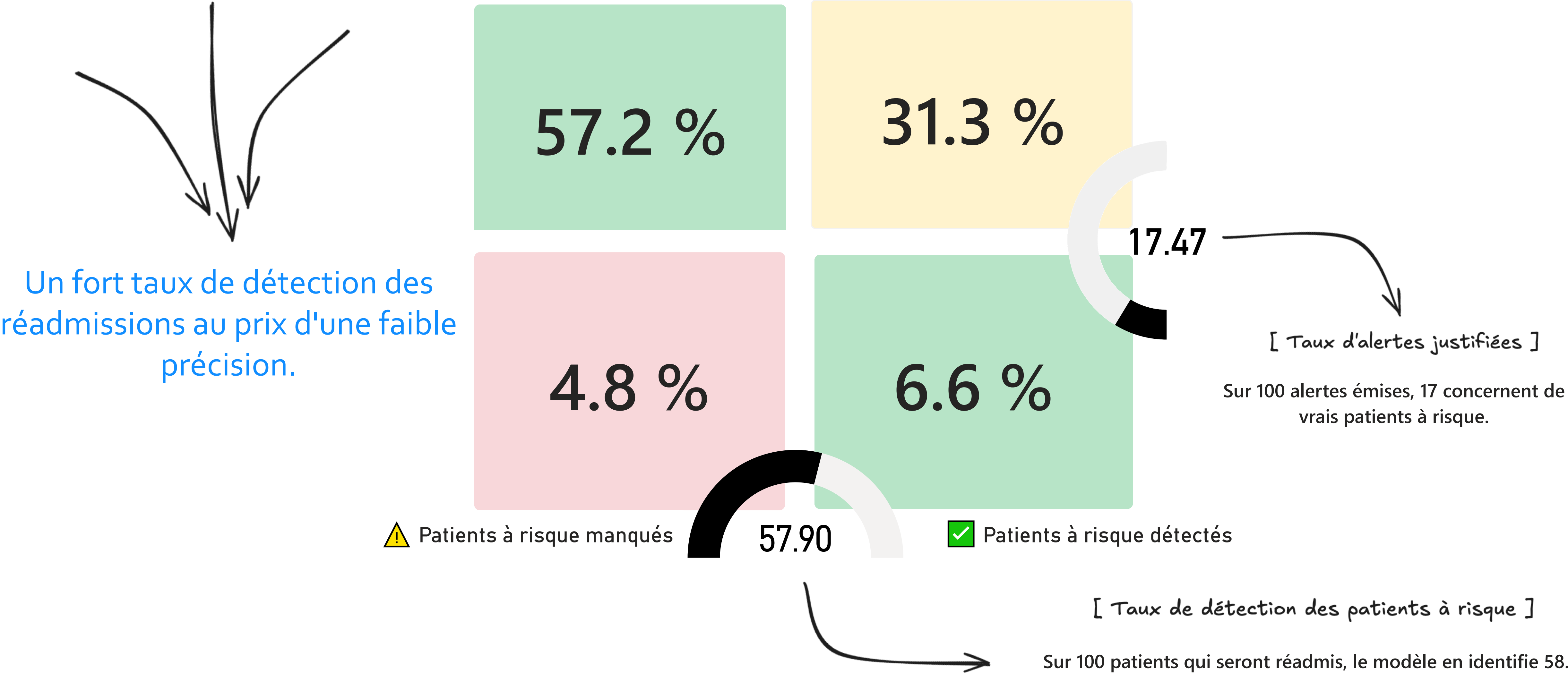
- Durée du Séjour
- Total Visites
- Nbre Médicaments prescrits
- Nbre de changement de posologie

Moyenne sur le total des hospitalisations :

0.29



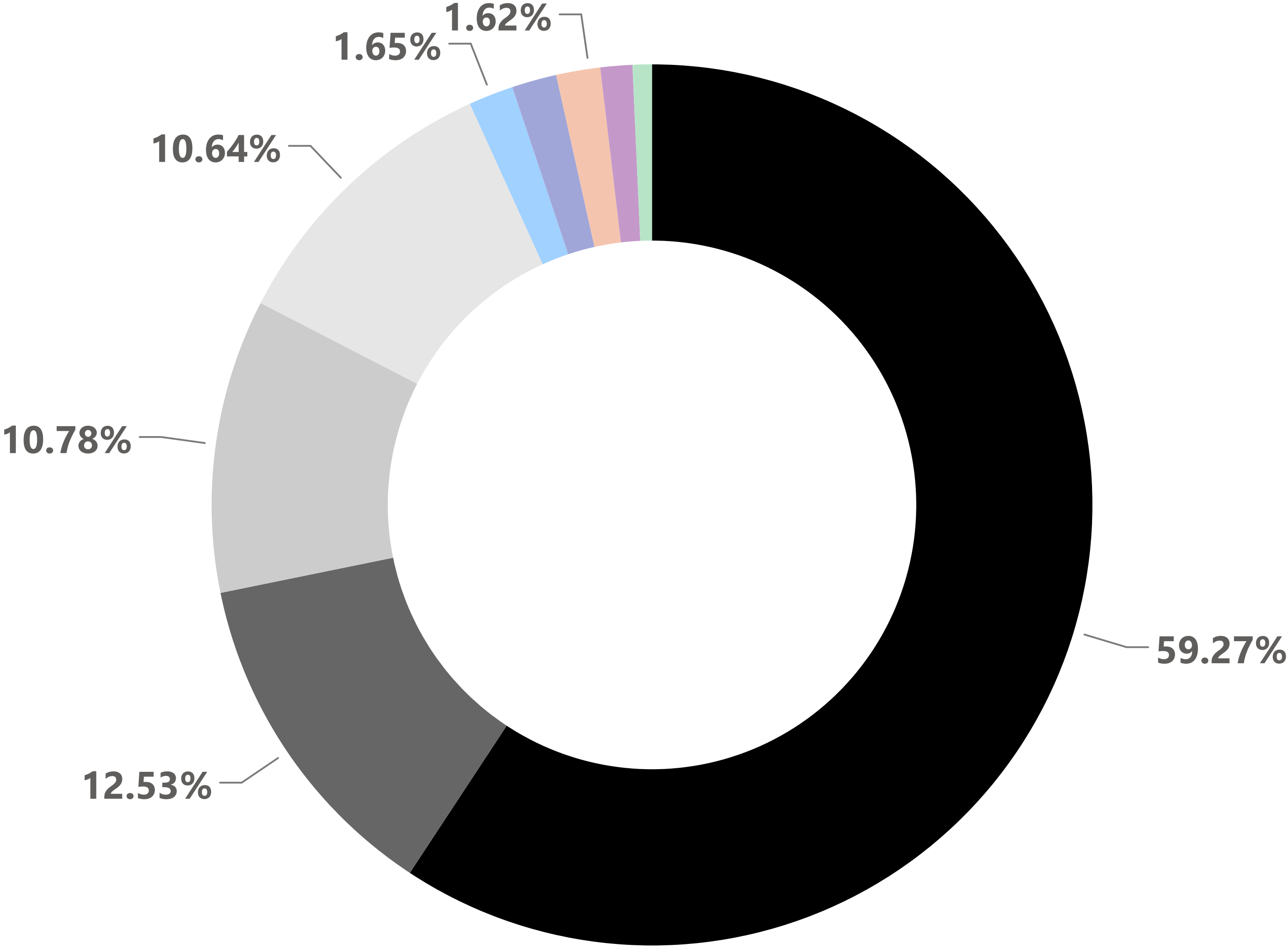
Un modèle volontairement bruyant : détecter avant tout.



Identification des facteurs prédominants de réadmission



- Facteurs**
- Score de visite
 - Retour au domicile
 - Transfert vers Maison de Repos
 - Nombre de diagnostics
 - Suivi / Rééducation
 - Transfert vers un hopital
 - Cancer primo-diagnostiqué
 - Consultation d'Oncologie
 - Cancer diagnostiqué





Réadmission : une prédiction difficile car multi-factorielle, que faire ?



Assurer une meilleure prise en charge des patients atteints de pathologies lourdes et chroniques,



Renforcer la prévention et l'information auprès des malades ET des aidants,



Envisager un **suivi médical à distance régulier** par télé-consultation,



Former patients et aidants à l'**auto-médication** et au contrôle glycémique régulier.



Un objectif chiffré :

Diminuer le % de réadmis chez les patients les plus à risque de

23.26 %

sous la barre des

12.35 %

de réadmission actuel.



Prévenir les réadmissions, un enjeu de santé...et de budget

Evaluation du potentiel :

soit 0 réadmission(s) évitée(s) par an sur le panel
le plus à risque, équivalent à une économie
brute annuelle de ~0 \$*

**calculé sur la base d'une économie moyenne de 2140\$ par réadmission évitée
(VA (2011, Health Care Management Science))*

% de réadmission chez les
patients les plus à risque

23.26

23.26

"" Diminuez-moi! ""

